

CAPÍTULO 10.21

Parasitosis – Primera Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Parasitosis — Parte I

Comparativa Rápida

TABLA 10.21.1: PARÁSITO VS CONTAGIO				
PARÁSITO	CONTAGIO	CLÍNICA CARACTERÍSTICA	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
Trichinella spiralis (Triquinosis)	Carne de cerdo mal cocinada	Mialgias generalizadas + fiebre + eosinofilia muy marcada (triada)	IgM triquina / Biopsia muscular	Albendazol o Mebendazol + AINE + Corticoides
Ascaris lumbricoides	Alimentos con deposiciones humanas	Asintomático o clínica abdominal inespecífica. Síndrome de Löffler : tos + fiebre + eosinofilia (fase pulmonar)	Parasitológico de deposiciones (huevos)	Albendazol o Mebendazol (+ Pamoato de pirantel para la familia)
Enterobius vermicularis (Oxiuros / Piduyes)	Fecal-oral + autoinfestación	Prurito anal nocturno	Test de Graham (cinta adhesiva zona perianal ≠ parasitológico de deposiciones)	Mebendazol (+ tratar toda la familia)
Taenia solium/saginata	Carne de cerdo/vaca (mal cocinada)	Asintomática. Déficit vitamina B12 (anemia megaloblástica)	Parasitológico (huevos o proglótidas)	Prazicuantel
Neurocisticercosis (T. solium)	Alimentos con deposiciones humanas (≠ carne de cerdo)	Mayoritariamente asintomática. Si great: convulsiones focales, hipertensión endocraneal, signos focales	TAC o RMN (hallazgo)	Si activo y sintomático: Prazicuantel + Corticoides. Si asintomático: Observar.

Claves de Eosinofilia Parasitaria

TABLA 10.21.2: TRIADA VS PARÁSITO		
TRIADA	PARÁSITO	
Mialgias + fiebre + eosinofilia	Triquinosis	
Tos + fiebre + eosinofilia	Ascaris (Síndrome de Löffler)	
Intercicia + fiebre + eosinofilia	Distomatosis (Clase 22)	

Notificación Obligatoria

- **Inmediata**: Triquinosis - No requiere: Ascariasis, Oxiuriasis (muy frecuentes en Chile)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
Paciente que consumió carne de cerdo en asado rural hace 2 semanas consulta por mialgias intensas generalizadas y retrooculares, fiebre de 38,5°C. El hemograma muestra 65% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Parasitosis - Primera Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Triquinosis (cerdo): MIALGIAS + fiebre + eosinofilia marcada. Diagnóstico: serología/biopsia muscular. Tratamiento: albendazol + corticoides. Notificación inmediata.
- Ascariasis (deposiciones humanas): generalmente asintomática. Síndrome de Loeffler: TOS + fiebre + eosinofilia (fase pulmonar). Tratamiento: albendazol + pamoato de pirantel.
- Oxiuriasis/pidulles: PRURITO ANAL. Diagnóstico: test de Graham (No parasitológico). Tratamiento: mebendazol + desparasitar familia.
- Teniasis (cerdo/vaca/pescado): carne con cisticercos. Puede producir déficit B12. Tratamiento: PRAZICUANTEL (no albendazol).
- Neurocisticercosis: contagio por deposiciones HUMANAS (no por cerdo). Mayoría asintomática. Si activa: prazicuantel/albendazol + corticoides. Si asintomática: observación.
- Diferencias clave de eosinofilia: triquina = mialgias, ascaris (Loeffler) = tos. Ambas con fiebre y eosinofilia.

EUNACOM CRITERIOS

Diferencia clave de contagio en Taenia: - **Teniasis**: ingestión de **cisticercos en carne de cerdo** → gusano intestinal adulto - **Neurocisticercosis**: ingestión de **huevos en deposiciones humanas** → quistes en SNC

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARASITOSIS - PRIMERA PARTE)

PREGUNTA 1

Paciente que consumió carne de cerdo en asado rural hace 2 semanas consulta por mialgias intensas generalizadas y retrooculares, fiebre de 38,5°C. El hemograma muestra 65% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Ascariasis con síndrome de Loeffler
- B) Triquinosis
- C) Neurocisticercosis
- D) Teniasis por *Tenia solium*
- E) Distomatosis hepática

PREGUNTA 2

Niño de 6 años con prurito anal nocturno. La madre refiere haber encontrado gusanitos blancos pequeños en la zona perianal. ¿Cuál es el examen de elección?

- A) Parasitológico seriado de deposiciones
- B) Test de Graham
- C) Hemograma con recuento de eosinófilos
- D) Colonoscopia
- E) Serología para *Enterobius*

PREGUNTA 3

Respecto a la neurocisticercosis, ¿cuál es la vía de contagio?

- A) Consumo de carne de cerdo mal cocida con cisticercos
- B) Consumo de alimentos contaminados con deposiciones humanas
- C) Consumo de carne de vaca mal cocida
- D) Contacto con perros infectados
- E) Consumo de plantas acuáticas contaminadas

RESUMEN: PARASITOSIS - PRIMERA PARTE

Esta clase aborda las parasitosis más relevantes: triquinosis, ascariasis, oxiuriasis, teniasis y neurocisticercosis. La triquinosis (*Trichinella spiralis*) se contagia por carne de cerdo mal cocida y se presenta con mialgias (retrooculares y generalizadas), fiebre y eosinofilia marcada, con CK elevada. Diagnóstico con serología o biopsia muscular. Tratamiento con albendazol/mebendazol más corticoides. Es de notificación inmediata. La ascariasis (*Ascaris lumbricoides*) se contagia por alimentos contaminados con deposiciones humanas, habitualmente asintomática. El síndrome de Loeffler (tos, fiebre y eosinofilia) ocurre durante la fase pulmonar del ciclo del parásito. Diagnóstico con parasitológico. Tratamiento con albendazol/mebendazol más pamoato de pirantel (paraliza el gusano antes de matarlo para evitar perforación). La oxiuriasis (*Enterobius vermicularis*/pidulles) produce prurito anal. Diagnóstico con test de Graham (no parasitológico). Tratamiento con mebendazol, desparasitando a toda la familia. La teniasis (*T. solium* por cerdo, *T. saginata* por vaca, *Diphyllobothrium latum* por pescado) puede producir déficit de vitamina B12. Diagnóstico con parasitológico, tratamiento con prazicuantel. La neurocisticercosis (*T. solium*) se contagia por alimentos contaminados con deposiciones HUMANAS (no por carne de cerdo). Habitualmente asintomática, puede producir epilepsia focal, cefalea e hipertensión endocraneana. Diagnóstico con neuroimagen (TAC/RMN). Tratamiento: prazicuantel o albendazol más corticoides si activo; anticonvulsivantes si sintomático; observación si asintomático e inactivo.